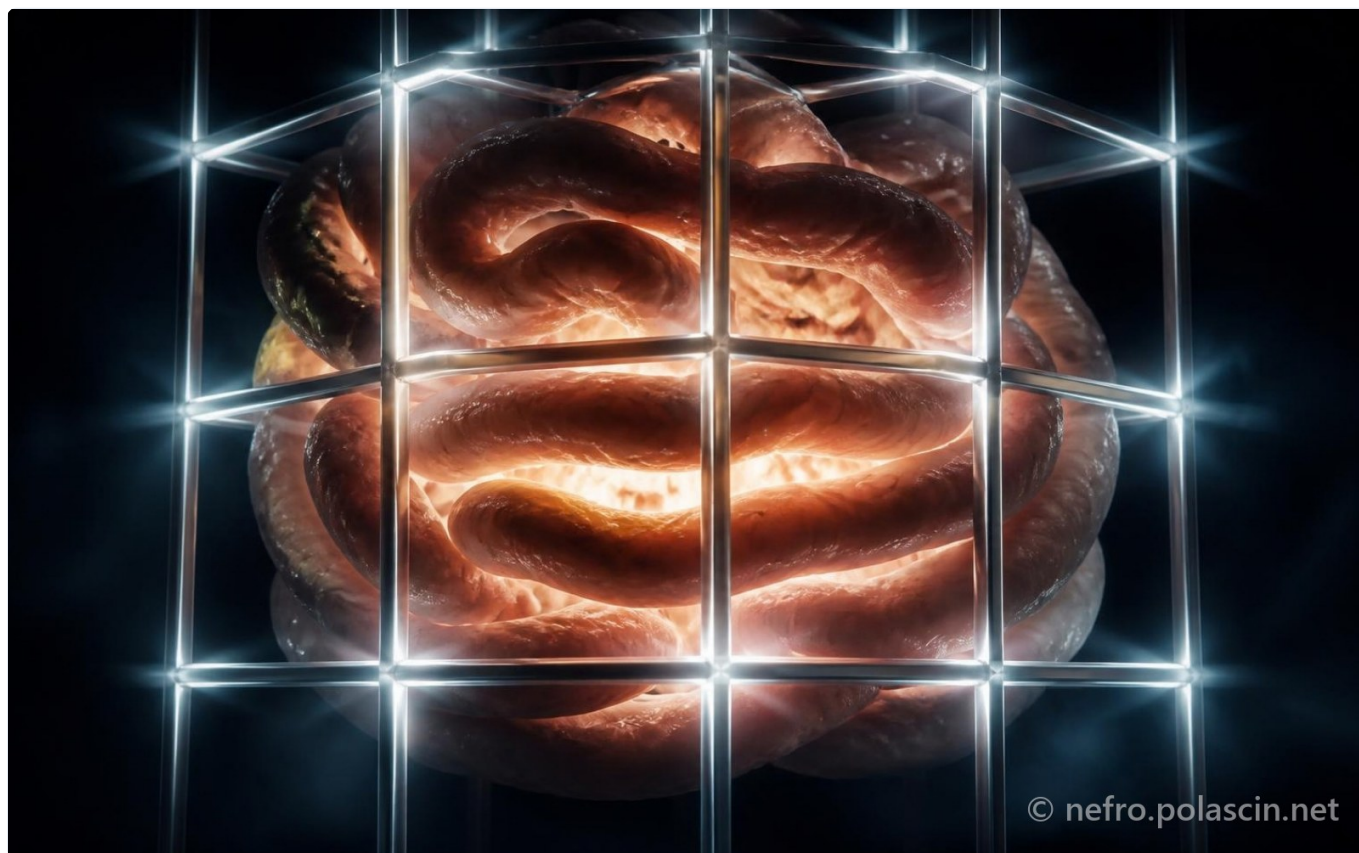


# „Gutmaxxing“: keď sa snaha o zdravé črevo zmení na rigidný protokol a čo to znamená v nefrologickej ambulancii

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Ilustračná scéna. Keď sa zo starostlivosti o črevo stane nemenný protokol, obmedzenie začne škodiť skôr než pomáhať.

Pojmom „gutmaxxing“ sa v online komunitách označuje snaha o maximálne „optimalizované“ trávenie: vysoký príjem vlákniny a bielkovín, sledovanie makroživín, kombinácie výživových doplnkov, opakované „detoxikačné“ a „očistné“ cykly a vyradovanie celých skupín potravín. Je súčasťou širšieho javu, ktorý spája sebazlepšovanie s číselnými cieľmi. Z pohľadu ambulancie nejde v prvom rade o to, čo pacient je — ale o to, **ako prísne dodržiava pravidlá, ktoré si stanovil**. A pre pacienta s chronickou chorobou obličiek (CKD) sú tieto pravidlá spravidla prevzaté z odporúčaní, ktoré preňho neplatia.

## Čo taký protokol zvyčajne obsahuje

- Číselné ciele pre bielkoviny a vlákninu, často prevzaté z fitness obsahu.
- Viacero výživových doplnkov naraz — probiotiká, vlákninové prípravky, proteínové koncentráty, kreatín, elektrolytové zmesi, bylinné prípravky.
- Vyradovanie skupín potravín (lepok, mliečne výrobky, niektoré rastlinné oleje, väčšina ovocia) bez preukázanej intolerancie alebo alergie.
- Opakované „očistné“ režimy a preplachy.
- Denné vykazovanie a kontrola dodržiavania pravidiel.

## Prečo je to nefrologická téma

Nefrológ sa s týmto javom stretáva v troch podobách. Prvou je pacient s CKD, ktorý si našiel „zdravý“ režim a nepovažuje ho za niečo, čo by mal v ambulancii spomenúť. Druhou je mladý pacient bez známeho ochorenia obličiek, ktorý prichádza s náhodne zisteným zvýšeným kreatinínom. Treťou je pacient, u ktorého sa za nutričným protokolom skrýva porucha príjmu potravy.

## Cieľové hodnoty pre bežnú populáciu nie sú cieľovými hodnotami pri CKD

Toto je najdôležitejšia praktická informácia celého článku. Hodnoty, ktoré v populárnych prehľadoch figurujú ako rozumné, sú pri CKD nad odporúčaným stropom:

| Situácia                               | Príjem bielkovín                                     | Poznámka                                                                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktívny dospelý bez ochorenia obličiek | Bežne uvádzané rozpätie približne 1,2 – 1,6 g/kg/deň | Populárne zdroje zároveň odrádzajú od dlhodobého prekročovania 2 g/kg/deň.                               |
| CKD G3 – G5 bez dialýzy                | <b>0,8 g/kg/deň</b>                                  | Odporúčanie KDIGO 2024; pri riziku progresie sa <b>neodporúča prekročiť 1,3 g/kg/deň</b> .               |
| Pacient na dialýze                     | Vyšší príjem než pri CKD bez dialýzy                 | Riziko je opačné — podvýživa a úbytok svalovej hmoty. Cieľ určuje nefrológ spolu s nutričným terapeutom. |

Rozdiel je zásadný. Cieľ 1,6 g/kg/deň prevzatý z fitness obsahu leží u pacienta s CKD nad hranicou, ktorú KDIGO neodporúča prekročiť. U 80-kilogramového pacienta ide o rozdiel medzi približne 64 g a 128 g bielkovín denne. Podrobnejšie sa touto otázkou zaoberá samostatný článok o mýtoch influencerov, na ktorý odkazujeme nižšie.

## Doplňky výživy a minerálový profil

Pri CKD platí, že „prírodné“ nie je synonymom „bezpečné“. Praktické riziká kombinovaných suplementačných režimov:

- **Draslík.** Rastlinné proteínové zmesi, zeleninové koncentráty a elektrolytové prípravky môžu obsahovať významné množstvo draslíka bez toho, aby to bolo zjavné z obalu.
- **Fosfor.** Fosforečnanové aditíva v spracovaných „proteínových“ výrobkoch sa vstrebávajú podstatne lepšie než fosfor viazaný v prirodzených potravinách.
- **Tekutiny a objem.** Vlákнинové prípravky vyžadujú dostatočný príjem tekutín, ktorý je pri pokročilej CKD alebo pri srdcovom zlyhávaní obmedzený. Naopak „očistné“ režimy môžu viesť k stratám tekutín a k prerénálnemu poškodeniu.
- **Bylinné prípravky.** Časť z nich je nefrotoxická alebo vstupuje do liekových interakcií; zloženie výživových doplnkov nepodlieha rovnakej kontrole ako zloženie liekov.

## Interpretácia kreatinínu

Vysoký príjem bielkovín, doplnky s kreatínom a vyšší podiel svalovej hmoty zvyšujú koncentráciu kreatinínu bez toho, aby klesla skutočná filtrácia. Pri pacientovi s takýmto režimom je preto pred záverom o „zhoršení funkcie obličiek“ namieste doplniť cystatín C, prípadne albuminúriu, a odber zopakovať po vysadení doplnkov.

## Kedy ide už o poruchu, nie o disciplínu

Hranica medzi starostlivosťou o zdravie a patologickým vzorcom nie je v obsahu diéty, ale v jej rigidite a v tom, čo sa stane pri jej porušení. Varovné signály:

- výrazná úzkosť, vina alebo pocit zlyhania pri odchýlke od protokolu,
- vyhýbanie sa spoločným jedlám, cestovaniu alebo rodinným udalostiam kvôli pravidlám,
- postupné rozširovanie zoznamu zakázaných potravín bez klinického dôvodu,
- opakované kontrolné správanie — váženie, fotografovanie, zapisovanie, vyhľadávanie zloženia,
- neúmyselné chudnutie, únava, výpadok menštruácie, znížená výkonnosť,
- presvedčenie, ktoré odoláva vysvetleniu a opiera sa o obsah zo sociálnych sietí.

Poznámka k terminológii: pojem „ortorexia“ sa v tejto súvislosti používa často, **nejde však o samostatnú diagnostickú jednotku v DSM-5**. Klinicky významné je to, či sú prítomné kritériá poruchy príjmu potravy — najmä vyhýbavo-reštriktívnej poruchy príjmu potravy — alebo obsedantno-kompulzívneho okruhu. Pri podozrení patrí pacient k psychiatrovi alebo klinickému psychológovi, nie k ďalšej nutričnej úprave.

## Praktický postup v ambulancii

1. **Pýtať sa cielene.** Otázka „dodržiavate nejakú diétu?“ často nestačí. Konkrétnejšie: „Máte nejaké pravidlá, čo môžete a čo nemôžete jesť? Čo sa stane, keď ich nedodržíte?“
2. **Vypísať všetky doplnky.** Vrátane proteínových práškov, elektrolytových zmesí, bylinných čajov a „očistných“ prípravkov. Pacienti ich spravidla neuvádzajú medzi liekmi.
3. **Prepočítať skutočný príjem bielkovín** na kilogram telesnej hmotnosti a porovnať ho s cieľom primeraným štádiu CKD, nie s cieľom z internetu.
4. **Zvážiť laboratórne vyšetrenie** podľa klinickej situácie: kálium, fosfor, vápnik, bikarbonát, kreatinín s cystatínom C, albuminúria, prípadne parametre nutričného stavu.
5. **Nezakazovať plošne.** Zákaz bez vysvetlenia motivovaného pacienta spravidla nezastaví — len ho prestane o režime informovať. Účinnejšie je ponúknuť konkrétny, číselne vyjadrený cieľ prispôbený jeho štádiu CKD.
6. **Vlákninu preferovať z potravy.** Pri CKD však treba zohľadniť obsah draslíka v jednotlivých zdrojoch a prípadné obmedzenie príjmu tekutín.

## Čo z tejto témy netreba preháňať

Nejde o doložený nefrologický rizikový faktor s vlastnou epidemiológiou. Neexistujú údaje o tom, koľko pacientov s CKD takýto režim dodržiava, ani štúdie o jeho vplyve na progresiu ochorenia obličiek. Tvrdiť, že „gutmaxxing poškodzuje obličky“, by bolo rovnakým typom nepodloženého zjednodušenia, aké sa vyčíta samotnému trendu. Doložené je niečo iné a skromnejšie: **pri CKD sú vysoký príjem bielkovín, nekontrolované doplnky a očistné režimy rizikové**, a rigidný protokol prevzatý zo sociálnych sietí je spoľahlivá cesta ku všetkým trom naraz.

## Záver

„Gutmaxxing“ je príklad toho, ako sa zdravotná motivácia mení na číselný protokol. Pre nefrológa z toho vyplývajú dve úlohy: preložiť cieľové hodnoty do podoby platnej pre dané štádium CKD — najmä pri bielkovinách, kde sa bežne odporúčané rozpätie s odporúčaním KDIGO míňa — a rozpoznať, kedy už za protokolom nestojí disciplína, ale porucha, ktorá si vyžaduje inú než nutričnú intervenciu.

## Súvisiace články

- [Strava a zdravie čreva podľa influencerov: kde vznikajú najčastejšie chyby](#)
- [Proteín a kreatín už nie sú výhradne „fitness téma“ a čo z toho plyní pre nefrológiu](#)
- [Mierne obmedzenie bielkovín môže pri chronickej chorobe obličiek zlepšiť prognózu](#)
- [Kreatín pri ochoreniach obličiek: bezpečnosť a prínos](#)
- [Kontrola draslíka pri CKD: edukovať, nie strašiť](#)

## Odborné zdroje

**1. Východiskový materiál:** Medscape. Gutmaxxing: Online Trend, Real-World GI Implications. 2026. Naratívny klinický komentár; autorstvo nie je v dostupnej časti materiálu jednoznačne uvedené, preto sa v tomto článku neuvádza. Odborné prahy a nefrologické súvislosti boli doplnené a overené podľa zdrojov nižšie.

**2. Odporúčanie pre príjem bielkovín pri CKD:** Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(4 Suppl):S117–S314. doi: [10.1016/j.kint.2023.10.018](https://doi.org/10.1016/j.kint.2023.10.018). Zdroj odporúčania 0,8 g/kg/deň pri CKD G3–G5 a praktického bodu o hranici 1,3 g/kg/deň pri riziku progresie.

**Poznámka k dôkazovému základu:** Číselné prahy pre príjem bielkovín pri CKD boli overené podľa odporúčania KDIGO 2024; rozpätia uvádzané pre bežnú populáciu pochádzajú z východiskového materiálu a platia pre osoby bez ochorenia obličiek. Údaje o prevalencii tohto správania medzi pacientmi s CKD ani o jeho vplyve na progresiu ochorenia obličiek nie sú k dispozícii a článok ich neuvádza. Klasifikácia varovných znakov porúch príjmu potravy je uvedená ako orientačná; diagnostiku vykonáva psychiater alebo klinický psychológ.

Text má odborný informačný charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie ani nutričné poradenstvo prispôbené konkrétnemu pacientovi a štádiu ochorenia obličiek.

